การดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยู่บ้าน(ต่อ)

3. หากมีอาการปวดสะโพกมาก ขาบวม หรือขามีลักษณะผิดรูป และไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได้ ให้รีบมาพบแพทย์
4. ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อสะโพกเทียมเคลื่อน หลุด
   - หากผู้ป่วยต้องการนอนตะแคง ให้เอาขาข้างที่ทำการผ่าตัดขึ้น และแทรกหมอนไว้ระหว่างขาทั้ง2ข้าง โดยระวังไม่ให้ขาข้างที่ทำผ่าตัดหุบเข้าด้านใน
   - การขึ้นลงบันไดเวลาก้าวขึ้นบันได ให้ใช้ขาข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดนำขึ้น และก้าวขาข้างที่ไดรับการผ่าตัดตาม เวลาลงบันได ให้ใช้ขาข้างที่ผ่าตัดนำลงมาก่อน แล้วจึงใช้ขาข้างที่ดีก้าวลงตาม
   - ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องหมุนข้อสะโพกเข้าด้านใน หรืองอข้อสะโพกมากๆ เช่น นั่งไขว่ห้าง นั่งเก้าอี้ที่มีความสูงของเบาะ นั่งต่ำกว่าระดับความสูงหัวเข่าขณะนั่งยืนลงน้ำหนักขาข้างที่ผ่าตัดและบิดตัว การยกของหนัก ก้มใส่รองเท้า ก้มหยิบของบนพื้นโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหยิบ การใช้ส้วมชนิดนั่งยอง ถ้าไม่มีอาจดัดแปลงใช้เก้าอี้ไม้เจาะเป็นช่อง วางครอบโถส้วม หากนั่งรถควรปรับเบาะให้เหยียดขาได้สุดและกางออก
5. เมื่อพบทันตแพทย์หรือเข้ารับการทำหัตถการ ต่าง ๆ ทางการแพทย์เช่น ทำผ่าตัดทางช่องท้อง หรือผ่าตัดรากฟัน ควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาเพื่อรับยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
6. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกินไป
7. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งแม้ไม่มีอาการผิดปกติ

หมายเหตุ: ข้อปฏิบัติในการทำกิจกรรม อาจปรับเปลี่ยนได้ เมื่อมีกิจกรรมใดที่ไม่แน่ใจ หรือสงสัย ควรปรึกษาแพทย์

Scan me

แผ่นพับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

วีดีโอการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

จัดทำโดย

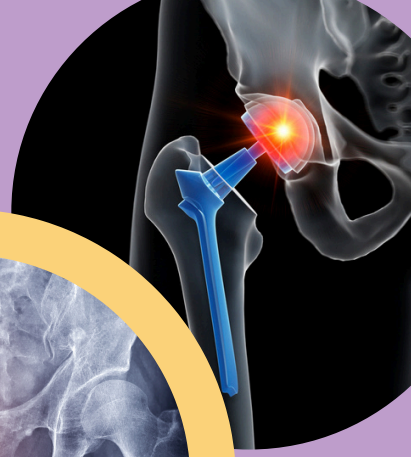
นางสาวลลิตา วาตานาเบ
พยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วยพิเศษ3/1 งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

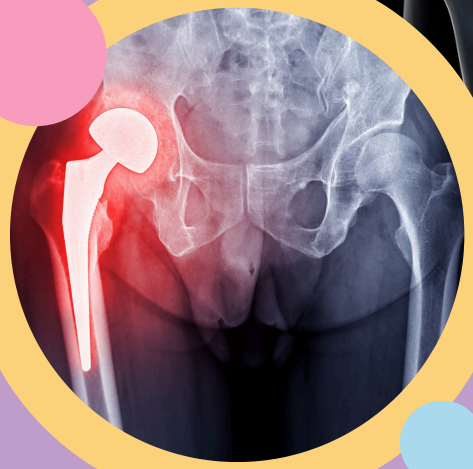
upmed@up.ac.th

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000

อ้างอิง

นางสาวเสาวภา อินผา. (2563). การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.





การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

หอผู้ป่วยพิเศษ 3/1

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

การปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

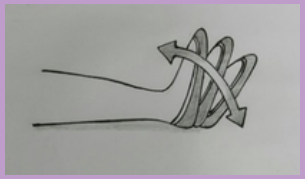
ข้อสะโพกเทียม เป็นวัสดุที่ทนทานแข็งแรงมีความหนาแน่นสูง ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนหัวกระดูกต้นขา และเบ้าสะโพก สามารถรับน้ำหนักตัวและทนต่อการสึกหรอได้ดี

ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถพบได้ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ได้แก่

1. การติดเชื้อของแผลผ่าตัด แผลจะมีลักษณะบวม แดงร้อน มีหนองไหลและมีไข้ร่วมด้วย
2. มีภาวะเส้นเลือดดำ อุดตัน ถ้าเกิดในปอด สมอง และหัวใจ อาจทำให้เสียชีวิตได้
3. การเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม
4.การหักของกระดูกบริเวณรอบข้อสะโพกเทียม ส่วนใหญ่มักพบบริเวณกระดูกต้นขา
5. ข้อสะโพกเทียมหลวมหรือสึกหรอ
6. เส้นประสาทบาดเจ็บ ทำให้กระดกข้อเท้าไม่ได้ ร่วมกับมีความรู้สึกชาบริเวณปลายเท้า

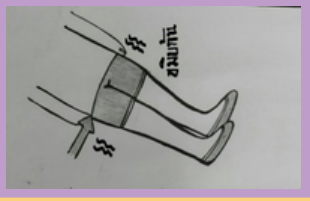
การดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

1. สังเกตแผลผ่าตัด ถ้ามีอาการปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับมีไข้ให้รีบมาพบแพทย์
2. ออกกำลังกายให้แข็งแรงโดยทำท่าบริหารต่างๆ ท่าละ10ครั้ง และทำ 3-4รอบต่อวัน ตามภาพดังต่อไปนี้



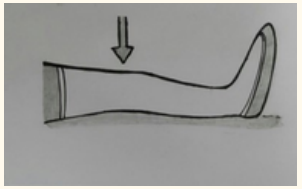
2.1 กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างช้าๆ ค้างไว้นับ 1-5 แล้วกระดกข้อเท้าลงค้างไว้นับ 1-5

2.2 เลื่อนส้นเท้าเข้าหาสะโพกจนสุด พร้อมกับงอเข่า โดยให้ยืดส้นเท้าวางไว้บนเตียงตลอดเวลา ระวังอย่าให้หัวเข่าหมุนเข้าด้านใน จากนั้นเหยียดขาออกตรง

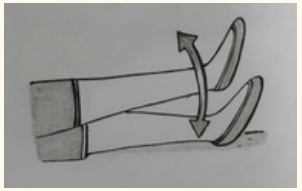


2.3 ขมิบก้น ให้ข้างไว้ และนับ 1-5

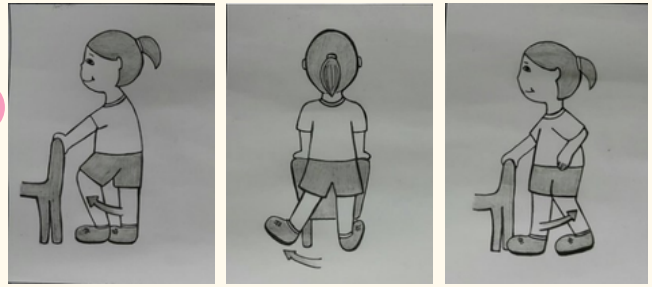
2.4 ลากขาข้างที่ได้รับการผ่าตัดไปทางด้านข้าง ขณะนอนอยู่บนเตียง จากนั้นจึงหุบขาเข้าที่เดิม



2.5 เกร็งกล้ามเนื้อต้นขา โดยเหยียดขาออกให้สุด และกดเข่าลงไปกับเตียง และนับค้างไว้นับ1-5 จากนั้นจึงผ่อนคลาย



2.6 นอนหงายเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาและยืดเข่าให้ตรงที่สุด ขณะที่เกร็งค่อยๆยกขาขึ้นจากเตียงสูง 2-3 นิ้ว ค้างไว้นับ1-5 แล้วค่อยๆวางลง



2.7 บริหารในท่ายืน โดยเกาะพนักเก้าอี้ หรือราวจับที่มั่นคงและบริหารดังนี้

<u>ท่าที่1</u> ยกขาข้างที่ผ่าตัดขึ้นมาทางข้างหน้าของลำตัว โดยยกไม่สูงเกินระดับเอวนับ 1-3 แล้วจึงลดขาลง

<u>ท่าที่2</u> จัดท่าให้สะโพก เข่าและเท้าชี้ไปด้านหน้า ยืนตัวตรง เหยียดเข่าให้ตึง จากนั้นกางขาข้างที่ผ่าตัดไปทางด้านข้าง และนับ1-3แล้วค่อยๆลดลงจนเท้ากลับมาแตะพื้น

<u>ท่าที่3</u> ยกขาข้างที่ผ่าตัดไปทางด้านหลัง พยายามยืดหลังให้ตรง ยกค้างไว้นับ1-3 แล้วค่อยๆ ลดขาลงมา เพื่อกลับมาสู่ท่ายืนตามปกติเหมือนเดิม